

Nie jesteś *sam/-a*

1–2% kobiet, 0,5% mężczyzn — życiowa chorobowość. Onset najczęściej 18–25 lat. Genetyka 50–60% odziedziczalności + środowisko + kultura. Mechanizm wielopoziomowy.

CZAS: 15 min · psychoedukacja · Normalizacja · motywacja do leczenia

ŹRÓDŁO: Hudson i in. (2007); Stice i in. (2013); Bulik i in. (2007); Caslini i in. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **dane epidemiologiczne** bulimii (sekcja 1), zobacz **czynniki ryzyka** — biologiczne, psychologiczne, środowiskowe (sekcja 2). Sekcja 3 — najczęstsze **współwystępowanie**. Sekcja 4 — Twoje notatki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hudson i in. (2007, NCS-R, N = 2980): **chorobowość życiowa bulimii** wynosi 1,5% kobiet i 0,5% mężczyzn. *Nie jesteś sam/-a*. Wiek początku najczęściej 18–25 rok życia (Stice i in. 2013). Rozkład płci 3:1 (kobiety:mężczyźni), ale BN u mężczyzn jest **poważnie niedoszacowana**. Bulik i in. (2007, bliźnięta): odziedziczalność BN to **50–60%**. Bulimia *nie* jest „chorobą bogatych dziewczyn z dietą” — to neurobiologiczne zaburzenie z silnym komponentem genetycznym, na które wpływają czynniki środowiskowe. Caslini i in. (2016): wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie zwiększa ryzyko BN **3-krotnie**.

01 Dane epidemiologiczne

1–2% KOBIEC

życiowa chorobowość. 0,5% mężczyzn (prawdopodobnie zaniżone). Hudson 2007, NCS-R.

ONSET: 18–25 LAT

Najczęściej w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Szczyt ok. 20 lat. Stice 2013.

50–60% ODZIEDZICZALNOŚĆ

Silny komponent genetyczny. Bulik 2007, badanie bliźniąt. To *nie* jest „wybór”.

Średni czas trwania nieleczonej bulimii to 5–10 lat (Keski-Rahkonen & Mustelin 2016). Pacjenci leczeni w ciągu 3 lat od początku objawów osiągają pełną remisję w 70% przypadków; po 10 latach — w 30–40% (Treasure i in. 2015). To *nie* wyrok — to choroba **leczalna**.

02 Czynniki ryzyka — model wielopoziomowy

BIOLOGICZNE · GENETYCZNE

Odziedziczalność 50–60% (Bulik 2007). Historia rodzinna ED, depresji, lęku. Zmienność genów receptorów serotoniny i dopaminy.

PSYCHOLOGICZNE

Perfekcjonizm, niska samoocena, interpersonalna wrażliwość, alexithymia (trudność rozpoznawania emocji), impulsywność.

ROZWOJOWE

Dietowanie w okresie dojrzewania — **najsilniejszy pojedynczy czynnik ryzyka** (Stice 2013). Wczesny rozwój fizyczny u dziewcząt. Komentarze rodziny o wadze.

TRAUMA

Caslini i in. 2016: wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie zwiększa ryzyko BN 3x. Inne traumy: zaniedbanie, emocjonalna przemoc.

SOCJOKULTUROWE · KULTURA SZCZUPŁOŚCI

Media idealizujące szczupłość, presja społeczna, filtry w mediach społecznościowych. Zawody związane z wyglądem (modeling, balet, sporty walki z kategoriami wagowymi). To *nie* jest „moda” — to systematyczna ekspozycja zwiększająca podatność.

03 Często współwystępowanie

Bulimia rzadko występuje samodzielnie. Hudson i in. (2007): **94,5%** osób z BN ma co najmniej jedno współwystępujące zaburzenie psychiczne. To *nie* jest „*komplikacja*” — to często część tego samego mechanizmu lub czynnik podtrzymujący.

DEPRESJA • 50–70%

Najczęstsze współwystępowanie. Często wtórna do BN (wstyd, izolacja), ale czasem pierwotna. Wymaga osobnej oceny i leczenia.

ZABURZENIA LĘKOWE • 30–50%

Uogólnione, społeczne, fobie. Często poprzedzają BN. Lęk i restrykcja często idą w parze — sztywne reguły jako próba kontroli.

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI • 30%

Najczęściej borderline (BPD) — łączy je impulsywność, regulacja emocji. Czasem zaburzenia osobowości lękowe. Wymaga dłuższego leczenia.

SUBSTANCJE • 20–40%

Alkohol, stymulanty (kontrola apetytu/wagi). Wysokie ryzyko u osób z BN typ purging. Wymaga zintegrowanego leczenia.

04 Moje notatki — czynniki w mojej historii

MOJE CZYNNIKI RYZYKA

— rodzinne, rozwojowe, psychologiczne; bez ocen, tylko obserwacja

CO U MNIE WSPÓŁWYSTĘPUJE

— depresja, lęk, inne; co warto zgłosić specjalście

Klucz: bulimia **nie jest wyborem** ani „*modą*” ani „*brakiem dyscypliny*”. 50–60% odziedziczalności (Bulik 2007) plasuje ją *obok* innych poważnych zaburzeń psychicznych z silnym komponentem biologicznym. **Genetyka nie jest wyrokiem** — to *podatność*, która aktywuje się w określonych warunkach środowiskowych (dietowanie, trauma, kultura szczupłości). Dlatego leczenie jest skuteczne: praca z czynnikami środowiskowymi (regularne jedzenie, redukcja reguł, praca z rdzeniem poznawczym) może **odwrócić** aktywację mechanizmu, nawet jeśli podatność biologiczna pozostaje. Hudson i in. (2007): mediana opóźnienia leczenia bulimii w USA to **4-8 lat** od początku objawów. To bardzo długo. Każdy rok wcześniej rozpoczętego leczenia poprawia rokowanie. Jeśli rozpoznajesz u siebie objawy — *nie czekaj*. Jeśli rozpoznajesz je u kogoś bliskiego — zachęć do konsultacji.